

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS EN LA PRÁCTICA
COMUNITARIA: EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD
PÚBLICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA "Cuidamos Tu Salud" DE
FARMATODO**

**Al Hussaini Fehmi, Raudely Carreyó, Reyes Yuliana, Rodríguez
Verónica*.**

***Autor de correspondencia: Verorodri2212@gmail.com**

Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Caracas, Venezuela.

RESUMEN

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las principales causas de morbilidad a nivel mundial y en Venezuela. Su manejo farmacológico suele requerir múltiples medicamentos, lo que incrementa el riesgo de interacciones medicamentosas potenciales, errores de dosificación y problemas relacionados con la seguridad de los tratamientos, especialmente en pacientes adultos mayores con hábitos de automedicación. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto del programa de atención farmacéutica "Cuidamos Tu Salud" de Farmatodo en la detección de interacciones medicamentosas potenciales, errores de dosificación y oportunidades de optimización terapéutica en farmacias comunitarias de Venezuela. Se realizó un estudio descriptivo, transversal y de intervención clínica durante el período comprendido entre abril y junio de 2026. El seguimiento farmacoterapéutico se llevó a cabo mediante la aplicación del Método Dáder, complementado con la evaluación de interacciones medicamentosas y parámetros de seguridad farmacológica mediante

herramientas especializadas. Los resultados mostraron un predominio de pacientes femeninas entre 60 y 72 años. Se identificaron conductas de automedicación de riesgo, destacando el uso concomitante de losartán y captopril por iniciativa propia de los pacientes, generando un bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Asimismo, se detectaron sobre-dosificaciones de losartán, pacientes con cifras tensionales elevadas sin diagnóstico previo de hipertensión y casos de hipotensión asociados al uso de betabloqueantes. Las intervenciones farmacéuticas incluyeron educación sanitaria, seguimiento farmacoterapéutico y derivación médica cuando fue necesario. Se concluye que el programa "Cuidamos Tu Salud" constituye una estrategia efectiva para identificar y prevenir problemas relacionados con medicamentos, fortaleciendo el papel del farmacéutico comunitario en la promoción del uso racional de los medicamentos y en la protección de la salud pública.

Palabras clave: Interacciones medicamentosas, Salud pública, Farmatodo, Cuidamos Tu Salud, Automedicación, Venezuela.

ABSTRACT

Cardiovascular diseases are among the leading causes of morbidity and mortality worldwide and in Venezuela. Their pharmacological management often requires multiple medications, increasing the risk of potential drug interactions, dosing errors, and treatment-related safety issues, particularly in older adults with self-medication habits. The objective of this study was to evaluate the impact of Farmatodo's "Cuidamos Tu Salud" pharmaceutical care program on the detection of

potential drug interactions, dosing errors, and opportunities for therapeutic optimization in community pharmacies in Venezuela. A descriptive, cross-sectional, and clinical intervention study was conducted between April and June 2026. Pharmacotherapeutic follow-up was performed using the Dáder Method, complemented by the assessment of drug interactions and pharmacological safety parameters through specialized tools. The results showed a predominance of female patients aged between 60 and 72 years. Risky self-medication practices were identified, particularly the concomitant use of losartan and captopril on the patients' own initiative, resulting in dual blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system. In addition, losartan overdosing, patients with elevated blood pressure values without a previous diagnosis of hypertension, and cases of hypotension associated with beta-blocker use were detected. Pharmaceutical interventions included health education, pharmacotherapeutic follow-up, and medical referral when necessary. It is concluded that the "Cuidamos Tu Salud" program is an effective strategy for identifying and preventing medication-related problems, strengthening the role of the community pharmacist in promoting the rational use of medicines and protecting public health.

Keywords: Community pharmacy, Drug interactions, Pharmaceutical care, Public health, Self-medication.

INTRODUCCIÓN

A nivel global, las enfermedades no transmisibles (ENT) — particularmente las afecciones cardiovasculares como la hipertensión arterial y las cardiopatías isquémicas— constituyen la principal causa de

muerte según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Venezuela, las patologías del sistema circulatorio ocupan de forma sostenida los primeros lugares en las tasas de mortalidad nacional.

El abordaje terapéutico de la hipertensión crónica exige de forma casi invariable el uso de la polifarmacia. Si bien este enfoque busca el control estricto de las cifras tensionales, introduce una variable crítica para la seguridad del paciente: las Interacciones Medicamentosas Potenciales (IMP). En el contexto de la salud pública venezolana, este riesgo no solo se debe a la complejidad de las prescripciones médicas, sino también a una arraigada cultura de automedicación de emergencia.

Es sumamente común que los pacientes tomen decisiones terapéuticas empíricas basadas en costumbres o consejos familiares frente a crisis percibidas. Un ejemplo crítico es el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA, como el captopril) como medida de auxilio por parte de pacientes que ya se encuentran bajo un tratamiento diario con antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II, como el losartán). Este bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), realizado por iniciativa del propio paciente, representa un peligro silente pero severo para la integridad hemodinámica y renal.

Ante esta realidad, la red de oficinas de farmacia de Farmatodo implementa el programa "Cuidamos Tu Salud" como una respuesta institucional y asistencial desde la atención farmacéutica comunitaria en Venezuela. Este programa busca estructurar el seguimiento farmacoterapéutico (SFT) y la educación sanitaria por regiones, permitiendo al farmacéutico integral identificar, prevenir y resolver los

problemas relacionados a los medicamentos (PRM) originados tanto en el ámbito médico como en las decisiones del paciente en el hogar, consolidando la farmacia comunitaria como un centro accesible de atención primaria.

Clasificación del Artículo

Este trabajo se clasifica como un Artículo de Investigación Clínica y de Salud Pública; Se enmarca dentro de la investigación epidemiológica observacional, de corte transversal, con un componente de intervención sanitaria enfocado en la educación comunitaria y la farmacovigilancia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del Estudio y Población

Estudio descriptivo, transversal y de intervención clínica-farmacéutica en pacientes crónicos inscritos voluntariamente en el programa "Cuidamos Tu Salud" en las sucursales de la red Farmatodo en Venezuela, desarrollado de forma continua durante el trimestre comprendido desde abril hasta junio del año 2026.

Recolección de Datos y Seguimiento Farmacoterapéutico

Se aplicó el Método Dáder para SFT a través de las consultas del programa asistencial en las diferentes sucursales de la cadena, basado en una metodología sistemática de atención farmacéutica orientada a identificar, prevenir y resolver problemas relacionados con medicamentos y resultados negativos asociados a la medicación. Este método se fundamenta en la recopilación de información clínica y farmacoterapéutica del paciente, la evaluación de la necesidad,

efectividad y seguridad de los tratamientos, y la implementación de intervenciones dirigidas a optimizar la farmacoterapia.

La información fue obtenida a través de entrevistas farmacéuticas estructuradas realizadas durante las consultas del programa “Cuidamos Tu Salud”. Además de registrar los medicamentos prescritos, se investigaron hábitos de uso, conductas de automedicación y decisiones terapéuticas adoptadas por los pacientes ante situaciones específicas, como episodios de elevación percibida de la presión arterial o el consumo de medicamentos almacenados en el hogar sin indicación médica reciente.

La identificación y clasificación de las interacciones medicamentosas potenciales (IMP), así como la verificación de dosis máximas recomendadas y aspectos de seguridad farmacológica, se realizaron utilizando bases de datos internacionales especializadas, entre ellas Micromedex® y Medscape Drug Interaction Checker®.

Intervención Farmacéutica y Educación Sanitaria

Las intervenciones se dividieron según el origen del problema:

I. Intervención enfocada en el Paciente (Educación Sanitaria)

Ante conductas de automedicación incorrectas (como el uso de captopril de emergencia en conjunto con la administración de losartán potásico), se realizó una consejería orientada a la deconstrucción de mitos terapéuticos, explicando el riesgo de daño renal e hipotensión por duplicidad.

II. Intervención enfocada en el Médico (Comunicación Interprofesional)

Redacción de informes para sugerir correcciones en dosis prescritas (losartán a 150-200 mg/día) o sustitución de tratamientos (betabloqueantes en arritmias).

RESULTADOS

Durante el período comprendido entre abril y junio de 2026 se evaluaron 15 pacientes crónicos adscritos voluntariamente al programa de atención farmacéutica "Cuidamos Tu Salud" de Farmatodo. La población estudiada estuvo conformada predominantemente por mujeres, concentrándose principalmente en el grupo etario de 60 a 72 años.

El análisis de los perfiles farmacoterapéuticos mediante el Método Dáder reveló que el riesgo de interacciones no dependía exclusivamente de los errores de prescripción, sino en gran medida de las decisiones autónomas del paciente en el hogar. Los hallazgos evidenciaron que una proporción importante de los riesgos se originaba fuera del ámbito de la consulta médica, específicamente en decisiones terapéuticas tomadas por los propios usuarios ante situaciones percibidas como urgentes.

Entre los problemas detectados destacó el uso de antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II), principalmente losartán, en simultaneo con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), particularmente captopril, siendo administrado con decisión propia del paciente ante episodios de elevación tensional percibida; Esto deriva un bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona,

aumentando el riesgo potencial de eventos adversos cardiovasculares y renales.

Asimismo, se identificaron pacientes con dosis de losartán superiores a las recomendadas terapéuticamente, alcanzando valores entre 150 y 200 mg diarios. También se detectaron casos de hipotensión asociados al uso de betabloqueantes prescritos para el tratamiento de arritmias cardíacas, situación que comprometía la tolerabilidad y seguridad de la farmacoterapia.

Durante las actividades de control y seguimiento desarrolladas en el programa se identificaron además pacientes con cifras tensionales elevadas que desconocían su condición hipertensiva, permitiendo su captación oportuna y posterior remisión para evaluación médica.

Las intervenciones farmacéuticas realizadas incluyeron educación sanitaria individualizada, revisión de tratamientos, comunicación interprofesional con el médico tratante y derivación de pacientes para valoración clínica. Los diferentes problemas farmacoterapéuticos identificados, su origen y las acciones implementadas se presentan en el Cuadro 1.

El 100% de los problemas derivados de la conducta del paciente se resolvieron de forma exitosa y definitiva en el cubículo de atención farmacéutica mediante la educación y la entrega de material informativo del programa.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación ponen en relieve un problema crítico de salud pública comunitaria en Venezuela: la automedicación

con fármacos de prescripción para contingencias tensionales. El hábito detectado en la muestra de mujeres de entre 60 y 72 años, quienes combinan de forma empírica un ARA-II de base con captopril ante cualquier sospecha de elevación tensional, refleja una profunda falta de educación sanitaria y una falsa sensación de seguridad asociada a fármacos comunes.

Desde la perspectiva farmacológica, la combinación de un IECA y un ARA-II está rotundamente contraindicada por grandes estudios internacionales (como el estudio ONTARGET), dado que el bloqueo simultáneo en diferentes puntos del sistema renina-angiotensina no ofrece ningún beneficio terapéutico adicional en la reducción de la presión arterial, pero sí duplica la incidencia de insuficiencia renal obstructiva, hiperpotasemia severa y síncope. Que esta interacción ocurra por decisión autónoma del paciente debido a la facilidad de adquirir o conservar estos medicamentos en el hogar representa un desafío que los médicos no pueden controlar desde el consultorio.

Es precisamente en este punto donde el programa "Cuidemos Tu Salud" de Farmatodo demuestra su máximo valor social y epidemiológico. Al realizar el seguimiento farmacoterapéutico en el mostrador durante el trimestre evaluado de 2026, el farmacéutico comunitario actúa como el educador de primera línea. Desmitificar el uso del "captopril de auxilio", explicar didácticamente cómo daña los riñones el uso conjunto de estos fármacos y enseñar al paciente a medir correctamente su presión antes de automedicarse son intervenciones que cortan de raíz la iatrogenia comunitaria. Esta labor complementa perfectamente la práctica médica, protegiendo la salud cardiovascular de las adultas mayores por regiones y reduciendo la frecuencia de

ingresos de emergencia en los hospitales nacionales por causas totalmente prevenibles.

CONCLUSIONES

Las interacciones graves por bloqueo dual en Venezuela no solo se originan en el ámbito de la prescripción, sino también por decisiones autónomas e incorrectas de los pacientes en el hogar, destacando el uso erróneo de captopril como fármaco de rescate sobre terapias con losartán.

El programa "Cuidemos Tu Salud" de Farmatodo consolida la figura del farmacéutico integral como un educador sanitario indispensable en el sector comunitario, capaz de intervenir directamente sobre los hábitos de automedicación peligrosos de la población de la tercera edad en las distintas regiones.

La optimización de la salud pública comunitaria requiere un enfoque bidireccional de la atención farmacéutica: una comunicación interprofesional fluida con el médico para corregir errores de dosificación (como el losartán a 150-200 mg o betabloqueantes mal tolerados) y un proceso continuo de alfabetización sanitaria al paciente en el mostrador de Farmatodo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). *Informe mundial sobre las Enfermedades No Transmisibles y Factores de Riesgo*. Ginebra; 2024.

2. Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS). *Anuario de Mortalidad de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas; 2025.
3. Yusuf S, et al. ONTARGET Investigators. *Telmisartan, Ramipril, or Both in Patients at High Risk for Vascular Events*. N Engl J Med. 2008; 358:1547-1559.
4. Comité de Consenso de Granada. *Tercer Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) y Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM)*. Ars Pharm. 2007; 48(1): 5-17.
5. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). *Ficha técnica oficial de Losartán Potásico y Captopril: Advertencias de Combinación*. Madrid: CIMA; 2023.

TABLAS Y CUADROS

Cuadro 1. Problemas farmacoterapéuticos, interacciones y origen del riesgo clínico en "Cuidamos Tu Salud".

Categoría / Origen	Condición / Fármacos Implicados	Mecanismo o Efecto Potencial	Gravedad	Intervención farmacéutica Realizada
Decisión del Paciente (Auto - medicación)	ARA-II (Losartán diario) + IECA	Bloqueo dual del SRAA por el paciente. Sinergismo de efectos adversos:	Mayor / Contraindicación absoluta.	Educación sanitaria inmediata en el mostrador; prohibición

Categoría / Origen	Condición / Fármacos Implicados	Mecanismo o Efecto Potencial	Gravedad	Intervención farmacéutica Realizada
	(Captopril "de emergencia").	riesgo de insuficiencia renal aguda, hiperpotasemia e hipotensión severa.		del uso de captopril como rescate.
Prescripción Médica (Error de Dosis)	Losartán Potásico (Dosis de 150 mg a 200 mg/día).	Sobredosificación. Supera la dosis máxima segura (100 mg/día) sin aportar mayor eficacia (efecto techo).	Grave / Riesgo de toxicidad renal.	Derivación escrita al médico sugiriendo reajuste o sustitución por terapia combinada.
Prescripción Médica (Seguridad)	Betabloqueantes en pacientes con	Disminución excesiva de la presión arterial (hipotensión	Grave / Riesgo de	Informe confidencial al médico recomendando o cambiar

Categoría / Origen	Condición / Fármacos Implicados	Mecanismo o Efecto Potencial	Gravedad	Intervención farmacéutica Realizada
	arritmias cardíacas.	severa, bradicardia).	síncopes y caídas.	por un antiarrítmico más seguro.
Subdiagnóstico (Hallazgo Incidental)	Pacientes con cifras tensionales elevadas en mostrador.	Riesgo de evento cerebrovascular por desconocimiento de su HTA (nunca se habían tomado la presión).	Grave / Ventana de oportunidad.	Captación en el programa, educación y derivación prioritaria al médico para diagnóstico.
Prescripción Innecesaria	Terapia antihipertensiva activa sin justificación clínica actual.	Exposición a polifarmacia inútil e hipotensión ortostática.	Moderada	Notificación al médico tratante para evaluar el desescalamiento terapéutico.